

CANCERS DES VOIES BILIAIRES :

I. Rappels anatomiques et physiologiques :

- ❖ Les voies biliaires drainent la bile produite par le foie vers le duodénum.
- ❖ Elles comprennent :
 - ✓ **Voies intra-hépatiques** : canaux biliaires segmentaires → canaux hépatiques droit et gauche.
 - ✓ **Voies extra-hépatiques** : canal hépatique commun + canal cystique = cholédoque (qui se jette dans le duodénum au niveau de l'ampoule de Vater).
- ❖ Fonction : transport de la bile (sels biliaires, bilirubine, cholestérol) essentielle à la digestion lipidique et à l'élimination de la bilirubine conjuguée.

1. VOIES BILIAIRES INTRA-HÉPATIQUES :

- ❖ Elles se trouvent à l'intérieur du foie et accompagnent les branches portales et artérielles dans les espaces portes.
- ❖ Leur rôle est de drainer la bile produite par les hépatocytes vers le hile hépatique.

A. Organisation :

- ❖ Les canalicules biliaires : fins conduits entre les hépatocytes, sans paroi propre.
- ❖ Ils convergent en canaux de Hering, puis en canalicules biliaires interlobulaires.
- ❖ Ceux-ci deviennent les canaux biliaires segmentaires, puis les canaux hépatiques droit et gauche.

B. Drainage segmentaire

- ❖ Chaque segment hépatique (classification de Couinaud) possède son propre canal biliaire.
- ❖ Les canaux hépatiques droit et gauche se réunissent au hilaire du foie pour former le canal hépatique commun.

C. Pathologie typique

- ❖ Cholangiocarcinome intra-hépatique
- ❖ Lithiase biliaire intra-hépatique (maladie de Caroli)
- ❖ Cholangite sclérosante primitive

2. VOIES BILIAIRES EXTRA-HÉPATIQUES :

- ❖ Elles commencent au hile du foie et se prolongent jusqu'à l'ampoule de Vater dans le duodénum.

A. Constitution

- ❖ Canal hépatique commun (résulte de la jonction des canaux hépatiques droit et gauche)
- ❖ Canal cystique venant de la vésicule biliaire
 - Leur union forme le canal cholédoque (ou canal biliaire principal).

B. Trajet du cholédoque

- ❖ Le cholédoque traverse quatre portions :
 - ✓ Portion sus-duodénale : dans le pédicule hépatique
 - ✓ Portion rétroduodénale : derrière la première portion du duodénum
 - ✓ Portion pancréatique : traversant la tête du pancréas
 - ✓ Portion intramurale : dans la paroi du duodénum, s'ouvrant au niveau de l'ampoule de Vater, souvent commune avec le canal pancréatique principal (canal de Wirsung).

C. Fonction :

- ❖ Conduire la bile vers le duodénum.
- ❖ La bile peut être stockée dans la vésicule biliaire via le canal cystique, puis libérée après un repas gras sous l'effet de la cholécystokinine (CCK).

D. Pathologie typique

- ❖ Lithiase du cholédoque.
- ❖ Cholangiocarcinome péri-hilaire ou distal.
- ❖ Angiocholite.
- ❖ Tumeur de l'ampoule de Vater.
- ❖ La frontière entre les voies intra- et extra-hépatiques se situe au hile hépatique.

- ❖ C'est une distinction chirurgicale majeure : c'est là que se joue la stratégie opératoire dans les tumeurs dites hilaires (Klatskin).

II. Définition et classification

- ❖ **Les cancers des voies biliaires regroupent :**
 - ✓ Cholangiocarcinomes intra-hépatiques
 - ✓ Cholangiocarcinomes péri-hilaires (tumeur de Klatskin)
 - ✓ Cholangiocarcinomes distaux (siège extrahépatique bas)
 - ✓ Cancer de la vésicule biliaire (entité à part, mais souvent associé)
- ❖ **Histologie :**
 - Dans 90 % des cas, adénocarcinome développant à partir de l'épithélium biliaire.

III. Épidémiologie

- ❖ **Rare mais en augmentation**, surtout en Asie du Sud-Est.
- ❖ **Incidence** : 1 à 2 /100 000 habitants/an (plus fréquente après 60 ans).
- ❖ **Légère prédominance masculine.**

IV. Facteurs de risque

- ❖ Cholangite sclérosante primitive (risque majeur)
- ❖ Lithiase biliaire intra-hépatique
- ❖ Kystes du cholédoque
- ❖ Infection chronique par *Clonorchis sinensis* ou *Opisthorchis viverrini*
- ❖ Exposition aux nitrosamines, thorotrast (ancien agent radiologique)
- ❖ Maladies inflammatoires chroniques du foie et des voies biliaires

V. Anatomopathologie

- ❖ Adénocarcinome **bien ou moyennement différencié**
- ❖ **Croissance** : infiltrante, périductale, ou nodulaire
- ❖ **Propagation** : locale (parenchyme hépatique), ganglionnaire, puis métastatique (foie, poumons, péritoine)

VI. Diagnostic clinique

1. Signes révélateurs :

- ❖ Selon le siège :
 - ✓ **Forme péri-hilaire ou distale** → ictère cholestatique progressif, prurit, urines foncées, selles décolorées, altération de l'état général
 - ✓ **Forme intra-hépatique** → masse hépatique, parfois découverte fortuite
 - ✓ **Douleur souvent discrète** (distension capsulaire)
 - ✓ **Pas de fièvre** (différencie d'une angiocholite)

2. Examen clinique :

- ❖ **Ictère franc**
- ❖ Prurit, amaigrissement, **parfois hépatomégalie dure**
- ❖ Pas de fièvre ni de frissons

VII. Examens complémentaires

1. Biologie :

- ❖ **Cholestase** : ↑ phosphatases alcalines, GGT, bilirubine conjuguée
- ❖ **Cytolyse modérée**
- ❖ **Marqueurs tumoraux** : CA 19-9, ACE (peu spécifiques)

2. Imagerie :

- ❖ **Échographie abdominale** : dilatation des voies biliaires, siège de l'obstacle
- ❖ **Scanner hépatique** : masse, extension loco-régionale, envahissement vasculaire
- ❖ **IRM + cholangio-IRM : examen de référence** pour la cartographie biliaire
- ❖ **Echo-endoscopie ou CPRE (cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique)** : diagnostic et

éventuellement drainage

VIII. Diagnostic différentiel

- ❖ Cancer du pancréas céphalique
- ❖ Lithiase enclavée du cholédoque
- ❖ Cholécystite chronique scléro-atrophique
- ❖ Cholangite sclérosante primitive non tumorale

IX. Traitement

1. Chirurgical (seul curatif)

- ❖ Résection complète R0 selon le siège :
 - ✓ **Intra-hépatique** → hépatotomie ou hépatectomie partielle
 - ✓ **Péri-hilaire** → hépatectomie + résection biliaire + reconstruction
 - ✓ **Distal** → duodéno-pancréatectomie céphalique (Whipple)
- ❖ Curage ganglionnaire systématique
- ❖ Marges histologiques déterminantes pour la survie

2. Drainage biliaire préopératoire

- ❖ CPRE ou drainage percutané, surtout si ictère important

3. Adjuvants :

- ❖ **Chimiothérapie (gemcitabine + cisplatine) pour formes avancées ou inopérables**
- ❖ Radiothérapie **palliative possible**

X. Pronostic :

- ❖ **Mauvais dans l'ensemble.**
- ❖ **Survie à 5 ans :**
 - ✓ 25–40 % si **résécable**
 - ✓ <10 % si **non résécable**
 - ✓ **Résection complète R0 = seul facteur de survie significatif.**

XI. Prévention et dépistage :

- ❖ **Suivi régulier des patients à risque** (cholangite sclérosante, kystes du cholédoque)
- ❖ Éviction des parasites biliaires dans les zones endémiques
- ❖ Dépistage **échographique et biologique (CA 19-9) dans populations à risque élevé**

XII. Points clés à retenir :

- ❖ Le cancer biliaire est **rare, souvent diagnostiqué tard.**
- ❖ Le symptôme cardinal est l'**ictère cholestatique indolore.**
- ❖ Le diagnostic repose sur l'**imagerie, la cholangio-IRM étant l'examen de choix.**
- ❖ La chirurgie **complète est le seul traitement curatif.**
- ❖ **Pronostic sombre, d'où l'intérêt du diagnostic précoce dans les groupes à risque.**